

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO

FOLICIL 5 mg comprimidos

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Cada comprimido contiene ácido fólico, 5 mg.

Excipiente(s): lactosa

Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1.

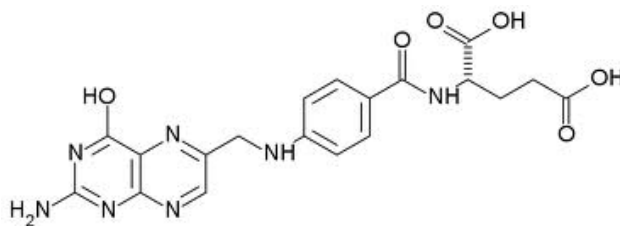
3. FORMA FARMACÉUTICA, ESTRUCTURA Y NOMBRE QUÍMICO

Comprimido.

Comprimidos de color amarillo, ranurados, circulares y biconvexos, con “Bial” grabado en una cara y “F|O” en la otra.

El comprimido se puede dividir en mitades iguales.

Fórmula estructural:



Nombre químico:

Ácido (2S)-2-[[4-[[[(2-Amino-4-oxo-1,4-dihidropteridin-6-il) metil] amino] benzoil] amino] pentanodioico

4. DATOS CLÍNICOS

4.1. Indicaciones terapéuticas

Folicil está indicado en el tratamiento y prevención de deficiencia de ácido fólico especialmente durante la gestación, lactancia y periodos de crecimiento más acentuado.

El tratamiento con ácido fólico también está indicado en la prevención de malformaciones del tubo neural (espinas bífidas, meningocele, anencefalia), especialmente en mujeres con antecedentes de hijo (o feto) con estas deficiencias.

Dado que la administración prolongada de barbitúricos, anticonvulsivantes, antimaláricos, laxantes, anovulatorios y algunos quimioterápicos puede causar deficiencia yatrofénica en ácido fólico, en estas situaciones está recomendada la administración de Folicil.

4.2. Posología y forma de administración

Posología

La posología y la duración del tratamiento deben ser establecidas por el médico.

Adultos: ½ a 1 comprimido, una o dos veces al día, de acuerdo con la situación clínica a tratar.

En la prevención de malformaciones del tubo neural: ½ comprimido al día, un mes antes de la concepción y durante el primer trimestre de gestación.

Niños: mitad de la dosis de adultos.

Forma de administración

Ingerir los comprimidos con un poco de agua, después o en el intervalo entre comidas.

4.3. Contraindicaciones

Hipersensibilidad al ácido fólico o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo

El ácido fólico no debe administrarse en caso de anemia cuya etiología sea desconocida, dado el riesgo de enmascaramiento de un cuadro de anemia perniciosa.

FOLICIL contiene lactosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a galactosa, deficiencia total de lactasa o problemas de absorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento.

4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

CLORANFENICOL: La administración simultánea de ácido fólico y cloranfenicol en pacientes con carencia de folatos, puede antagonizar la respuesta hematopoyética al ácido fólico.

FENITOÍNA: En los pacientes epilépticos, tratados con fenitoína, la terapia con medicamentos conteniendo ácido fólico puede aumentar el metabolismo de la fenitoína, disminuir sus concentraciones séricas y aumentar la frecuencia de las crisis convulsivas.

4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia

El ácido fólico puede utilizarse con seguridad durante el embarazo y la lactancia. La deficiencia de ácido fólico aparece en estas situaciones, recomendándose Folicil como forma de prevención.

4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas

La influencia de Folicil sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante.

4.8. Reacciones adversas

Muy frecuentes ($\geq 1/10$), Frecuentes ($\geq 1/100$, $< 1/10$), Poco frecuentes ($\geq 1/1.000$, $< 1/100$), Raras ($\geq 1/10.000$, $< 1/1.000$), Muy raras ($< 1/10.000$), incluyendo los casos aislados.

Trastornos del sistema inmunológico:

Raras: Fenómenos de hipersensibilidad, como eritema, fiebre, prurito y broncospasmo.

Frecuencia no conocida: Reacción anafiláctica.

Trastornos gastrointestinales:

Raras: Anorexia, náuseas, distensión abdominal y flatulencia

Notificación de sospechas de reacciones adversas:

Es importante notificar las sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del sistema nacional de notificación de farmacovigilancia.

4.9. Sobredosis

No se han notificado casos de sobredosis. Cuando se administran dosis elevadas, el ácido fólico es eliminado en la orina.

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1. Propiedades farmacodinámicas

Código ATC: B03B B01- Ácido fólico

El ácido fólico es una importante coenzima para el metabolismo celular. Después de la absorción por el tracto digestivo, el ácido fólico es reducido rápidamente, dando lugar a formas activas que participan en numerosas reacciones metabólicas esenciales para la vida, tales como la síntesis de purinas, síntesis de nucleótidos pirimidínicos e interconversión de aminoácidos (serina en glicina, histidina en ácido glutámico, homocisteína en metionina).

5.2 Propiedades farmacocinéticas

Por vía oral, el ácido fólico es rápidamente absorbido en el tracto gastrointestinal, principalmente en la parte proximal del intestino delgado. Los poliglutamatos, formas naturales de folatos, son enzimáticamente hidrolizados en el tracto gastrointestinal en formas monoglutámicas de ácido fólico, antes de su absorción. La mucosa del duodeno y la parte alta del yeyuno son ricas en dihidrofolato-reductasa, capaz de realizar la metilación de los folatos reducidos que son absorbidos. Tras la administración oral, el pico plasmático máximo se alcanza entre 30 y 60 minutos. La concentración plasmática normal de folatos varía de 0,005-0,015 mcg/ml. En lo general, concentraciones plasmáticas inferiores a 0,005 mcg/ml indican deficiencia de folatos y concentraciones inferiores a 0,002 mcg/ml conducen a anemia megaloblástica.

El ácido tetrahidrofólico y sus derivados son distribuidos en todos los tejidos corporales; el hígado contiene cerca de la mitad del total de las reservas de folatos. Los folatos son concentrados activamente en el LCR, con concentraciones normales de aproximadamente 0,016-0,021 mcg/ml. El ácido fólico es una vitamina hidrosoluble del complejo B y siendo la vía renal su principal vía de eliminación no se produce acumulación en el cuerpo. Después de administración oral de una dosis única de 0,1 a 0,2 mg de ácido fólico en adultos sanos, apenas una pequeñísima cantidad de ácido fólico aparece en orina. Cuando se supera la reabsorción tubular renal máxima, después de administraciones orales superiores a las necesidades diarias, el folato es excretado intacto en la orina. Cerca de 0,05 mg de las reservas normales de folatos son eliminadas diariamente por excreción fecal y urinaria.

5.3. Datos preclínicos sobre seguridad

Los datos de los estudios no clínicos no muestran riesgos especiales para los seres humanos según los estudios convencionales de farmacología de seguridad, toxicidad de dosis repetidas, genotoxicidad, potencial carcinogénico, toxicidad para la reproducción y el desarrollo.

6. DATOS FARMACÉUTICOS

6.1. Lista de excipientes

Ludipress® [lactosa monohidrato, povidona (Kollidon® K30), crospovidona (Kollidon® CL)] y estearato de magnesio.

6.2 Incompatibilidades

No procede.

6.3. Periodo de validez

3 años.

6.4. Precauciones especiales de conservación

Conservar por debajo de 30°C. Conservar en el embalaje original.

6.5. Naturaleza y contenido del envase

Blister de PVC/Alu. Cada caja contiene 10, 20 o 60 comprimidos.

Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases.

6.6. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones

Ninguna especial.

7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Bial- Portela & Cª S.A.
À Av. da Siderurgia Nacional
4745-457 S.Mamede do Coronado – Portugal

8. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO

Octubre 2021

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Abdel-Salam G, Czeizel AE. A case-control etiologic study of microcephaly. *Epidemiology* 2000; 11 (5):571-5.
2. AHFS Clinical Drug Information [Internet]. Folic acid.
3. Bailey LB, Cerda JJ. Iron and folate nutriture during life cycle. *World Rev Nutr Diet* 1988; 56:56-92.
4. Butterworth CE, Jr., Bendich A. Folic acid and the prevention of birth defects. *Annu Rev Nutr* 1996; 16:73-97.
5. Butterworth CE, Jr., Hatch KD, Macaluso M et al. Folate deficiency and cervical dysplasia. *Jama* 1992; 267 (4):528-33.
6. Carl GF, Smith ML, Furman GM et al. Phenytoin treatment and folate supplementation affect folate concentrations and methylation capacity in rats. *J Nutr* 1991; 121 (8):1214-21.
7. Chowers Y, Sela BA, Holland R et al. Increased levels of homocysteine in patients with Crohn's disease are related to folate levels. *Am J Gastroenterol* 2000; 95 (12):3498-502.
8. Conclusiones Científicas CMDh
9. Czeizel AE, Timar L, Sarkozi A. Dose-dependent effect of folic acid on the prevention of orofacial clefts. *Pediatrics* 1999; 104 (6):e66.
10. Ellison J, Clark P, Walker ID et al. Effect of supplementation with folic acid throughout pregnancy on plasma homocysteine concentration. *Thromb Res* 2004; 114 (1):25-7.
11. Frelut ML, de Courcy GP, Christides JP et al. Relationship between maternal folate status and foetal hypotrophy in a population with a good socio-economical level. *Int J Vitam Nutr Res* 1995; 65 (4):267-71.
12. French AE, Grant R, Weitzman S et al. Folic acid food fortification is associated with a decline in neuroblastoma. *Clin Pharmacol Ther* 2003; 74 (3):288-94.
13. Fuller, N.J., et al., The effects of dietary folate and zinc on the outcome of pregnancy and early growth in rats. *Br J Nutr*, 1988. 59(2): p. 251-9.
14. Giovannucci E, Stampfer MJ, Colditz GA et al. Multivitamin use, folate, and colon cancer in women in the Nurses' Health Study. *Ann Intern Med* 1998; 129 (7):517-24.
15. Guay F, et al. Effects of folic acid and vitamin B12 supplements on folate and homocysteine metabolism in pigs during early pregnancy. *Br J Nutr*, 2002. 88(3): p. 253-63.
16. Guney O, Canbilen A, Konak A et al. The effects of folic acid in the prevention of neural tube development defects caused by phenytoin in early chick embryos. *Spine* 2003; 28 (5):442-5.
17. Hess SY, Zimmermann MB, Brogli S et al. A national survey of iron and folate status in pregnant women in Switzerland. *Int J Vitam Nutr Res* 2001; 71 (5):268-73.

18. Jiang R, Hu FB, Giovannucci EL et al. Joint association of alcohol and folate intake with risk of major chronic disease in women. *Am J Epidemiol* 2003; 158 (8):760-71.
19. Lambie DG, Johnson RH. Drugs and folate metabolism. *Drugs* 1985; 30 (2):145-55.
20. Lashner BA, Heidenreich PA, Su GL et al. Effect of folate supplementation on the incidence of dysplasia and cancer in chronic ulcerative colitis. A case-control study. *Gastroenterology* 1989; 97 (2):255-9.
21. Martindale 35 ed Phamaceutical press 2007. Folic Acid. 1779.
22. Matte JJ, Girard CL, Tremblay GF. Effect of long-term addition of folic acid on folate status, growth performance, puberty attainment, and reproductive capacity of gilts. *J Anim Sci*, 1993. 71(1): p. 151-7.
23. McPartlin J, Halligan A, Scott JM et al. Accelerated folate breakdown in pregnancy. *Lancet* 1993; 341 (8838):148-9.
24. MMWR. Knowledge and use of folic acid by women of childbearing age--United States, 1995. *Jama* 1995; 274 (15):1190.
25. MRC Vitamin Study Research Group. *Lancet* 1991; 338 (8760):131-7.
26. Nensey YM, Arlow FL, Majumdar AP. Aging. Increased responsiveness of colorectal mucosa to carcinogen stimulation and protective role of folic acid. *Dig Dis Sci* 1995; 40 (2):396-401.
27. Olson RE. Water-soluble vitamins. In Munsen PL, editor. *Principles of Pharmacology*. New York:Chapman; 1995. p.965-969.
28. Shrubsole MJ, Jin F, Dai Q et al. Dietary folate intake and breast cancer risk: results from the Shanghai Breast Cancer Study. *Cancer Res* 2001; 61 (19):7136-41.
29. Tavares E, Gomez-Tubio A, Murillo ML et al. Folic acid intestinal absorption in newborn rats at 21 day postpartum: effects of maternal ethanol consumption. *Life Sci* 1999; 64 (22):2001-10.
30. Wald NJ, Law MR, Morris JK et al. Quantifying the effect of folic acid. *Lancet* 2001; 358 (9298):2069-73.
31. Wald NJ. Folic acid and neural tube defects: the current evidence and implications for prevention. *Ciba Found Symp* 1994; 181:192-208; discussion -11.
32. Wentzel P, Gareskog M, Eriksson UJ. Folic acid supplementation diminishes diabetes- and glucose-induced dysmorphogenesis in rat embryos in vivo and in vitro. *Diabetes* 2005; 54 (2):546-53.